PROTOCOLLO 33

Automobilizzazione assistita dell'ATM

Insegnare al paziente una mobilizzazione sicura da eseguire a casa

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Artralgia, ipomobilità	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Ipomobilità che richiede stimoli quotidiani
- ✓ Mantenimento dei risultati tra le sedute
- ✓ Pazienti collaboranti

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: seduto, gomito appoggiato.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Seduto, gomito appoggiato al tavolo.



Presa
Pollice pulito sui molari inferiori del lato da trattare.



Trazione
Leggera trazione verso il basso e in avanti.



Controllo
Movimento lento davanti allo specchio.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Tempo	3 x 30 secondi
Frequenza	2 volte al giorno
Intensità	stiramento lieve, mai dolore

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Verifica l'esecuzione in seduta
- ✓ Fornisci istruzioni scritte
- ✓ Controlla l'igiene delle mani

Errori da evitare

- ! Forza eccessiva
- ! Eseguire con dolore acuto
- ! Postura scorretta del capo

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Automobilizzazione	Trazione lieve e mantenuta con il pollice sui molari	3 x 30 secondi, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** L'automobilizzazione mantiene i guadagni ottenuti in seduta e aumenta l'autonomia del paziente.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.